
**RESUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT**

MELEX®

Anxiolytique

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

MELEX, 1 mg, (par) comprimé

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1 mg Mexazolam.

Pour les excipients voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1 Indications Thérapeutiques

MELEX est indiqué dans le traitement de l'anxiété associée ou non à des états psychoneurotiques. Les benzodiazépines sont indiquées uniquement en cas de situations graves, incapacitantes ou originant des états de souffrance.

4.2 Posologie et Mode d'administration

La dose de MELEX sera adaptée individuellement en fonction de la sévérité des symptômes et l'âge du patient.

Adultes: dose moyenne de 1 à 3 mg, par jour, de préférence en 3 prises.

Sujets âgés: ne pas excéder la dose de 1,5 mg par jour.

Enfants: MELEX n'est pas à usage pédiatrique.

Le traitement de l'anxiété devra être le plus court possible. Le patient devra être réévalué régulièrement et le besoin d'un traitement continu sera aussi réévalué, surtout en absence de symptômes. La durée globale du traitement ne doit pas excéder 8 à 12 semaines, y compris la période de réduction de la posologie. Dans certains cas, il pourra s'avérer nécessaire de prolonger le traitement au-delà des périodes préconisées. Ceci suppose l'évaluation de l'état du patient par un médecin spécialiste.

De toute façon, le traitement doit être initié avec la dose minimale prescrite.

En cas d'oubli d'une ou plusieurs doses, ne pas prendre la dose si 1 heure s'est écoulée. Ne pas prendre la dose double pour compenser la dose oubliée.

Il est recommandé de surveiller régulièrement le patient en début de traitement car il peut s'avérer nécessaire de réduire la dose ou la fréquence d'administration afin d'éviter un surdosage dû à l'accumulation.

4.3 Contre-indications

Hypersensibilité au mexazolam ou à quelqu'un de ses excipients. Myasthénie grave, hypersensibilité aux benzodiazépines, insuffisance respiratoire grave, syndrome de l'apnée du sommeil et insuffisance hépatique grave.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

Dépendance- Le traitement par les benzodiazépines peut entraîner une dépendance physique et psychique. Le risque de dépendance augmente en fonction de la dose et de la durée du traitement, et est plus grand en cas d'antécédents d'alcoolisme ou toxicomanie. Une fois établie la dépendance physique, l'arrêt abrupt du traitement sera accompagné des symptômes de sevrage, pouvant se manifester par des céphalées, douleurs musculaires, anxiété exacerbée, tension, inquiétude, confusion et irritabilité. Dans des cas plus graves: déréalisation, dépersonnalisation, hyperacousie,

endormissement et fourmillement des extrémités, hypersensibilité à la lumière, au bruit et au contact physique, hallucinations ou crise épileptique.

Rebond d'anxiété: À l'arrêt du traitement, il peut survenir un syndrome transitoire, les symptômes ayant menés au traitement par les benzodiazépines réapparaissent sous forme exacerbée. Il peut être accompagné d'autres réactions, y compris des changements d'humeur, de l'anxiété ou troubles du sommeil et inquiétude. Le risque d'apparition des phénomènes de sevrage/rebond étant accru après l'arrêt abrupt du traitement, on recommande une réduction progressive de la dose.

Durée du traitement: La durée du traitement devra être la plus courte possible, et en fonction de l'indication, mais ne doit pas excéder 8 à 12 semaines y compris la période de réduction de la posologie. Dans certains cas il pourra être nécessaire de prolonger le traitement au-delà des périodes préconisées. Ceci suppose des évaluations de l'état du patient. En début de traitement il peut être utile d'informer le patient que le traitement aura une durée limitée et que la réduction de la dose se fera progressivement. Le patient doit être averti de la possibilité d'un phénomène de rebond afin de minimiser l'anxiété qui pourrait découler des symptômes liés à l'arrêt du traitement.

Quand on utilise une benzodiazépine à longue durée d'action comme le mexazolam on ne doit pas changer pour une autre benzodiazépine à courte durée d'action, car cela pourrait entraîner de symptômes de sevrage.

Amnésie: Les benzodiazépines peuvent provoquer une amnésie antérograde, susceptible d'apparaître dans les heures qui suivent la prise; donc, pour réduire le risque, les patients doivent assurer une période ininterrompue de sommeil de 7-8 heures (voir effets indésirables).

Réactions paradoxales et psychiatriques: Les benzodiazépines peuvent provoquer inquiétude, agitation, irritabilité, agressivité, illusions, furie, cauchemars, hallucinations, psychoses, comportement inapproprié et autres effets indésirables du comportement. Elles imposent l'arrêt du traitement. Des réactions paradoxales ont été rapportées chez les schizophréniques

Patients spéciaux: Il est recommandé de réduire la posologie chez le sujet âgé (voir posologie), et chez l'insuffisant respiratoire chronique, à cause du risque de dépression respiratoire.

Les benzodiazépines ne sont pas indiquées dans le traitement des patients avec insuffisance hépatique grave car elles peuvent déclencher une encéphalopathie.

Les benzodiazépines ne constituent pas le traitement primaire des troubles psychotiques.

On ne doit pas utiliser les benzodiazépines isolément pour traiter la dépression ou l'anxiété associée à une dépression (à cause du risque de suicide chez ces patients).

La plus grande prudence est recommandée en cas d'antécédents d'alcoolisme ou toxicodépendance.

MELEX doit être utilisé avec beaucoup de prudence chez les patients ayant des altérations des fonctions cardiaque, rénal ou hépatique, et chez les patients ayant une lésion cérébrale organique.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

La consommation d'alcool au cours du traitement est déconseillée- majoration par l'alcool de l'effet sédatif des benzodiazépines. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.

Prendre des précautions en cas d'association à des dépresseurs du système nerveux central.

Majoration de l'effet dépressif central quand on associe le mexazolam à des antipsychotiques (neuroleptiques), hypnotiques, anxiolytiques/sédatifs, antidépresseurs, analgésiques narcotiques, antiépileptiques, anesthésiques et antihistaminiques sédatifs.

Dans le cas des analgésiques narcotiques il peut avoir une majoration de l'euphorie augmentant la dépendance physique.

Chez les animaux d'expérience on a observé les interactions suivantes: *Médicaments qui ont majoré l'effet du mexazolam:* chlorpromazine, halopéridol, diazépam, ciproheptadine, aminopirine, phénobarbital, éthanol, sulpiride, trichlorméthiazide et alpha-méthyl dopa. *Médicaments qui ont antagonisé l'effet du mexazolam:* imipramine, amitriptiline et chlorpheniramine.

Médicaments qui n'ont montré aucune interaction avec le mexazolam: diphénylhidantoïne, scopolamine butylbromide, gerfanate, propranolol et pindolol.

4.6 Grossesse et allaitement

Quoique les études effectuées chez l'animal n'aient mis en évidence aucun effet tératogène, l'innocuité du mexazolam n'est pas établie chez la femme enceinte. Les benzodiazépines peuvent entraîner des malformations congénitales quand on les administre pendant le premier trimestre de la grossesse. Si la prise de doses élevées de MELEX à la fin de la grossesse ou pendant l'accouchement s'avère nécessaire, cela peut être à l'origine, à la naissance, d'hypothermie, hypotonie et détresse respiratoire modérée chez le nouveau-né.

Les enfants nés de mères ayant pris chroniquement des benzodiazépines pendant la grossesse peuvent avoir développé une dépendance physique, et peuvent souffrir des symptômes de sevrage pendant la période postnatale.

On ne doit pas administrer le mexazolam aux mères allaitantes car il peut être trouvé dans le lait maternel.

Toute femme en âge de procréer doit avertir son médecin en cas de grossesse ou de doute de grossesse.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

La sédation, amnésie, altérations de l'attention et de la fonction musculaire résultantes de l'administration de MELEX peuvent affecter négativement l'aptitude à la conduite et à l'utilisation de machines. Si la période de sommeil s'avère insuffisante, ceci augmente la probabilité d'altération de l'état de vigilance.

4.8 Effets Indésirables

Les effets indésirables des benzodiazépines sont presque toujours en rapport avec leur action pharmacologique et se manifestent par une somnolence journalière, asthénie, baisse de vigilance, confusion, fatigue, céphalées, sensation de tête vide, faiblesse musculaire, ataxie ou diplopie.

Avec le mexazolam on a rarement rapporté (<0,1%) des altérations des mouvements de la langue, hypotension, sensation de tête vide, nausées, vomissements, anorexie, malaise gastrique, douleur gastrique ou abdominale, diarrhée, symptômes d'hypersensibilité (des éruptions cutanées, par exemple), réduction de la libido, élévation de la phosphatase alcaline, anémie et leucopénie. On a rapporté très rarement (0,1 - 5%) des cas de somnolence, vertiges, étourdissements, céphalées, ataxie, sécheresse de bouche, faiblesse, augmentation de l'aspartate aminotransférase, de l'alanine aminotransférase et du gamma-glutamyl-transpeptidase.

En règle générale les effets apparaissent les premiers jours du traitement et disparaissent en continuant la médication.

Amnésie

Une amnésie antérograde est susceptible d'apparaître quand on prend des doses thérapeutiques mais le risque est accru quand on augmente les doses. Les effets amnésiques peuvent être en rapport avec des comportements inappropriés (voir précautions).

Dépression

Une dépression préexistante peut faire surface au cours du traitement avec les benzodiazépines

Réactions psychiatriques et paradoxales

Chez certains sujets les benzodiazépines peuvent provoquer des réactions graves telles qu'inquiétude, agitation, irritabilité, agressivité, illusions, furie, cauchemars, hallucinations, psychoses, comportement inapproprié et autres effets indésirables du comportement. L'enfant et le sujet âgé y sont davantage exposés.

Dépendance

Même à doses thérapeutiques MELEX peut développer de la dépendance physique: l'arrêt du traitement peut déclencher des phénomènes de sevrage ou rebond (voir précautions). Une dépendance psychique est possible. Il a été rapporté des cas d'abus dans l'utilisation des benzodiazépines.

4.9 Surdosage ou Intoxication

À l'instar d'autres benzodiazépines, un surdosage de MELEX ne représente pas une menace de mort, à moins qu'on l'associe à d'autres déprimeurs du système nerveux central, y compris l'alcool.

Dans le traitement d'un surdosage il faut toujours tenir compte de la possibilité d'ingestion d'autres produits.

En cas de surdosage de MELEX, antérieur à 1 heure, l'induction de vomissement sera pratiquée si le patient est conscient, ou à défaut, un lavage gastrique avec protection des voies aériennes, pour prévenir l'aspiration du vomissement. S'il n'y a aucun avantage dans le lavage gastrique on doit administrer du charbon activé pour réduire l'absorption du médicament. Les fonctions respiratoire et cardiovasculaire seront objet de vigilance en unité de soins intensifs.

Les signes de surdosage par les benzodiazépines se manifestent par dépression du système nerveux central pouvant aller de la somnolence au coma. Dans les cas légers, les symptômes incluent somnolence, confusion mentale et léthargie; dans les cas plus graves on espère de l'ataxie, hypotension, détresse respiratoire, rarement coma et très rarement mort.

L'administration de flumazénil (un antagoniste spécifique pour les récepteurs des benzodiazépines) peut être utile comme antidote.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Code ATC: N05 BA

MELEX est une benzodiazépine. En règle générale, les benzodiazépines opèrent comme déprimeurs du système nerveux central, capables de produire tous les niveaux de dépression, pouvant aller de la sédation légère à l'hypnose et au coma, en fonction de la posologie.

Les sites précis et le mode d'action ne sont pas encore entièrement élucidés, mais ils semblent être moyennés à travers le neuromédiateur acide gamma-aminobutyrique (GABA), par la stimulation de récepteurs spécifiques. Le GABA ainsi que le chlorures peuvent augmenter la liaison à ces récepteurs.

Effets sédatifs – On a démontré à travers des expériences menées sur des souris, des rats et des singes que le mexazolam provoque une inhibition plus grande du comportement querelleur, de la violence, de l'agressivité que le diazépam. Des études faites sur des chats et des lapins suggèrent que ces effets sédatifs peuvent être le résultat de l'action du médicament sur le système limbique, y compris amygdales et hypothalamus.

Effets anticonvulsifs – On a prouvé après des expériences faites sur des souris, rats et des singes que le mexazolam provoque un effet inhibiteur plus fort que le diazépam dans les convulsions provoquées par l'action du bemegride et du pentetrazol.

Effets myorelaxants – le mexazolam a inhibé la rigidité décérébrée et a déprimé l'activité des neurones moteurs gamma chez les chats.

Effets dans la fonction motrice – Chez les souris, les rats et les chiens on a vérifié que l'influence du mexazolam sur la fonction motrice (par exemple, inhibition de la fonction motrice spontanée, effet myorelaxant, inhibition du réflexe de récupération et effet ataxique) est limitée.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Après la prise orale du mexazolam, on n'a pas détecté la substance inchangée dans le sang. On a seulement trouvé quelques métabolites CND (clornordiazepam) et COX (cloroxazepam). On pense que le mexazolam peut être hydroxylé dans le foie et conjugué à travers de voies métaboliques, un du type de la benzodiazépine (métabolites actifs) et l'autre du type de la benzophénone (métabolites inactifs).

Le CND est le métabolite plasmatique principal du mexazolam. Avec une dose unique de mexazolam, on atteint la concentration sérique maximale du CND après 1-2 heures. Le volume de la distribution apparente est de 150 L. Le modèle pharmacocinétique employé est du type bicompartimental. Après l'administration réitérée, les demies vies du CND et du COX sont longues (130-200 h).

La liaison du CND et COX aux protéines est > 90%.

Moins de 10% de la dose de mexazolam administrée est éliminée sous forme de métabolites dans l'urine, étant donné que la plupart du médicament est excrétée dans la bile. Le COX représente > 50% de la quantité totale des métabolites excrétés, et on les trouve essentiellement conjugués.

5.3 Données de sécurité pré cliniques

On a mené des expériences sur diverses espèces d'animaux, y compris la souris, le rat, le lapin, le chien et le singe et on a observé une grande marge de sécurité et une capacité toxique très basse. En fait, le LD₅₀ pour un usage oral a été de 4.687 mg/kg dans le rat, de 8.100 mg/kg dans le rat Wistar-Imamichi et de 1400 mg/kg dans le rat Fischer.

Dans des études de toxicité sous aiguë (10, 30, 125, 250, 500 et 1500 mg/kg, oralement, 5 semaines) on a seulement vérifié de la mortalité dans le groupe auquel on a administré 1500 mg/kg. On a observé une hyperatrophie des hépatocytes avec des doses égales ou supérieures à 250 mg/kg, mais celle-ci a disparue avec la discontinuation du médicament. Le mexazolam administré oralement au cours de 26 semaines à des rats qui ont pris des doses quotidiennes de 2, 10, 50 ou de 125 mg/kg, a démontré que le poids du foie, des reins et des glandes surrénales a augmenté chez les femelles qui recevaient la dose la plus élevée. En plus, l'examen histologique n'a pas montré d'altérations significatives. On n'a pas trouvé d'altérations dans la copulation ou dans la fertilité des rats mâles (2, 10 ou 20 mg/kg pendant 9 semaines); on n'a pas trouvé d'effets mortels ou tératogènes dans les fœtus des rats femelles (2, 10 ou 20 mg/kg, à partir du 14^{ème} jour avant la copule jusqu'au 7^{ème} jour de la gestation). L'administration de mexazolam pendant la période d'organogenèse (chez le rat – 2, 10 ou 20 mg/kg/ par jour pendant 11 jours; chez le lapin – 0.04, 0.2, 1 ou 5 mg/kg/ par jour pendant 13 jours) n'a pas provoqué la mort ou d'effets tératogènes dans les embryons et dans les fœtus du rat. L'administration du mexazolam pendant la période périnatale et l'allaitement (rats – 2, 10 ou 20 mg/kg/ jour pendant 4 semaines à partir du 17^{ème} jour de la gestation) n'a pas provoqué d'altérations pendant l'accouchement, l'allaitement ou chez les nourrissons (déformations externes, différenciation du temps postnatal et capacité de reproduction). Le mexazolam n'a pas présenté du potentiel mutagénique *in vitro*, dans le test de réversion et dans le test Rec-assay. On a recherché l'antigénicité du mexazolam dans les cobayes, et on n'a démontré aucune évidence d'antigénicité.

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Mannitol, Amidon de maïs, Hydroxypropyl-Cellulose, Stearat de calcium, Sulfate laurylique de sodium.

6.2 Incompatibilités

Sans objet.

6.3 Durée de conservation

Blisters de PVC/Alu: 5 ans.

Blisters d'Alu/Alu: 3 ans.

6.4 Précautions particulières de conservation

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C. À conserver dans l'emballage d'origine

6.5 Nature et contenu de l'emballage

Blisters de PVC/Aluminium ou Alu/Alu. Emballages de 30 comprimés

6.6 Instructions pour l'utilisation et la manipulation

Pas d'exigences particulières.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

BIAL –Portela & C^a S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado - PORTUGAL

8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

1842/06/10

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Date de première autorisation: 2006.03.15

Date du dernier renouvellement: 2010.11.30

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE